Pacient 3 r.č. 323456/3333 poj.

tel. +

Propouštěcí zpráva

Hospitalizace: 5 dní

RA: onkologicky negativní

OA: **spinoCa hrtanu, pT3N0M0, G2, R0, p16-**
- 2026 st.p.totální laryngektomii + lobektomii ŠŽ l.dx.+ BND bilat. II-V
- 26 st.p.implantaci PEG
- 26 st.p. adjuvantní RT (lůžko hypopharyngo-laryngu/LU krku bilat., 70Gy/56Gy/35Fr)st.p. lakunární iCMP v povodí ACM vlevo 06/24 (konzervativní postup), RBBB chron., hypertenze, EF 70%, diastolická dysfunkce I. st., sklerosa Ao chlopně s lehkou reg. (dle ECHO 01/26), exfumator, anemie posthemoragická 02/26, duodenální vředy Forrest III 02/26, cholestatická hepatopatie (susp. DILI), APPE v dětství
st. p. zavedení perkutánní gastrostomie 1/2026

EA: v kontaktu s inf. onemocněním nebyl

SA:

PA: je v důchodu

FA: dle dokum.
Nolpaza 40mg tbl.1-0-0,
Kinito 50mg tbl.1-1-1,
Trombex 75mg tbl.0-1-0,
Mucosolvan 2ml+F1/1 2ml 1-1-1 do nebulizace,
Flixotide inh. 125mcg/dáv 1-1-1,
Enalapril 5mg tbl.1-0-1,
Enap H 10/25mg tbl.1-0-0,
Rosucard 40mg tbl.0-0-1,
Agen 5mg tbl.1-0-1,
Lactulosa 667mg/ml dlp.,
Berodual 2ml inh. 3x/den,
Acidum folicum tbl.1-0-0,
Euthyrox 25mcg tbl.1-0-0,
Neurol 0,5mg tbl.0-0-1 dlp.,
Citalec 20mg tbl.1-0-0, vazelina lokálně na kanylu,
Tiapridal 100mg tbl.1-1-1 při neklidu,
Mirtazapin 15mg tbl.0-0-1,
Alprox 0,025mg tbl.1-1-1,
Linola radioderm lokálně na RT pole 3-4x denně.

Abusus: exfumator od 25, před iCMP 40cig/den, alkohol příležitostně

ALERGIE: neguje

CAVE: syndrom suchého oka, protruze bulbů od dětství

Nynější onemocnění:

Pacient vstupně vyšetřen na traumatologii a neurologii pro pád s úderem do hlavy, k došetření kolapsového stavu předán na interni od., stan A.
Subj.: komunikuje písemnou formou, není schopen mluvit pro tracheostomii, dnes šel na záchod, tam ve stoje při močení náhle pád, nepamatuje si na okolnosti, nepředcházely palpitace, stenokardie nemá ani neměl, jen na chvíli ztratil vědomí, po nabytí vědomí bez zmatenosti, křeče asi nebyly, pomočený nebyl, jazyk si nepokousal. Uhodil se do hlavy, a do boku, bok ještě trochu pobolívá ale analgetika nyní nepotřebuje. Dýchá se hůř dlouhodobě, chtěl by vyšetřit na ORL, naposledy tam byl v pátek, má krusty v trachei. Neguje, dysurie, dyspepsie. Při vertkalizaci dušnost pro potíže s tracheostomií.
Příjem tekutin prý dostatečný.

Status praesens:

VĚDOMÍ: při vědomí, orientován, spolupracuje pisemnou formou. CELKOVÉ PŘÍZNAKY: bez klidové dušnosti, přiměřené hydratace i výživy, není meningeální KŮŽE: kůže normálního koloritu bez známek cyanosy a ikteru. HLAVA: normocefalická. Bulby normotonické, Zornice isokorické s reakcí na obě kvality. Spojivky růžové. Jazyk nepovleklý plazí středem, KRK: symetrický, NKŽ nezvýšena, karotidy pulsují symetricky bez šelestu, lymfat. uzliny v typických lokalizacích nehmatám, štítná žláza nezvětšena, HRUDNÍK: fysiologicky klenutý, SRDCE: AS pravidelná, ozvy ohraničené, šelest neslyším, PLÍCE: dýchání sklípkové, symetrické, bez vedlejších patolog. fenomenů, poklep plný jasný, BŘICHO: v niveau, měkké, prohmatné, nebolestivé, bez patolog. rezistencí. bez známek peritoneálního dráždění,játra v oblouku, slezina nenaráží, tapotement bilat. negativní, peristaltika normokinetická, HKK: normální

Propouštěcí zpráva - pokračování

nález, DKK: bez otoků a bez známek zánětu, varixy bilat 0, pulzace v periferii bilat. hmatné, bez trofických změn. Vyšetření per rectum: neindikuji.

EKG:

EKG: AS reg, SR 75/min, PQ 200ms, QRS 160ms, QT 420ms, RBBB, ST-T změny v rámci bloku (změny již popsány v minul.)

Vyšetření:

ORL konzilium, , Spinocelulární karcinom hrtanu vpravo (supraglotis, glotis), T3N0M0, p16-, G2, stadium IV
- st. p. krustózní tracheitidě
- st. p. totální laryngektomii a blokové krční disekci oboustranně 2st. p. adjuvantní radioterapii od 13.4.
- st. p. zavedení perkutánní gastrostomie 1/2026

Pacient nyní hospitalizován na interní klinice po pádu na hrudník a hlavu. Pro bolest hrudníku se mu špantě odkašlává. Dýchá se také trochu hůře.
eupnoe, bez inspiračních fenoménu, vytažena plastová kanyla, poté okolí poradiačně lehce zarudlé a lehce prosákle, bez fluktuace, provedena endoskopie, kanál s středně velkou krustou ve střední části, peanem vytažena dále, poté trachea zcela volná až po karinu, bez krust, poté opět zavedena plastová kanyla
Závěr: trachea s krustou - pacheostomické kanyly

Doporuění:
1) péče o kanylu dle potřeby, při přicpání vytáhnout očistit, okolí promazat vazelínou, v případě obtížné reinzerce možno použít kovovou kanylu, vzduch zvhčovat
2) dostatečná analgetizace
3) ORL kontrola

Konziliární vyšetření,

Přijat 2026, Hyponatrémie s hypochlorémií, Synkopa v.s. vasovagální, CT mozku bez hemoragie, bez jiných ložisek, St. po totální laryngectomii pro spinocelulární karcinom hrtanu, St. po implantaci PEG 1/2026. Dále podrobně v dokumentaci FNO. ICM v povodí ACM vlevo 6/2024, konzervativní postup. Alergie 0, bolest 0. Psychiatrické konzilium 2026, Depresivní reakce. Medikace vícečetná, Citalec 20 mg 1-0-0, Tiapralan 100 mg 1-1-1, Mirtazapin 15 mg 0-0-0-1, Alprox 0,25 mg 1-0-1, při bolesti Zaldiar.
Nález klinického farmaceuta z 8.7.2026, prostudován. Podávaná psychofarmaka lze drtit, Tiaprid a Citalec jsou i v kapkách. Opatrnost a monitorování při komediaci s rizikem prodloužení QTc (citalopram, mirtazapin, tramadol). Citalec se může podílet na rozvoji hyponatrémie.
Anamnéza: Z předchozího konzilia plyne, že pracoval jako stavbyvedoucí, později jako vedoucí odboru výchovy. . Exfumator, dříve 40 cigaret/den.
No, subj.: Pacient leží v lůžku, verbální komunikace není možná, pac. je po laryngectomii. Psát nyní nechce, je spokojen s léčbou tak, jak je nastavena. Dle sester vše dostává do PEG, výživa Fresubinem. Malé množství tekutin polkne, doma snad polkne trochu jogurtu.
Obj.: Vědomí lucidní, plně orientován. Léčen antidepresivy. Je bez známek deprese, bez suicidálních tendencí, které t.č. nelze spolehlivě vyloučit. Pacient je bez delirantních symptomů, bez hrubší deteriorace kognitivních funkcí. **Závěr:** Reakce na stres F43.2
Doporučení:
Optimální hydratace a výživa. Dohled sestrou, bezpečné větrání. Je schopen léčby na standardním oddělení. Není nezbytná akutní hospitalizace na psychiatrii. Z hlediska QTc intervalu vysaďte Citalec, nahraďte lékem Trittico 75 mg 2/3-2/3-0 až 1-1-0 tbl. K posílení antidepresivních účinků je možno zvýšit Mirtazapin na Mirtazapin 30 mg 0-0-0-1 tbl. Tiapralan a Alprox ponechejte. Riziko SIADH vyřeší náhrada Citalecu antidepresivem Trazodon a navýšením Mirtazapinu. Léčba bez Citalecu bude lépe udržitelná dlouhodoběji. Léky dále drtit a podávat do PEG. Kontrola psychiatrem při potřebě. Pacienta je možno propustit do péče rodiny, je schopen léčby v LDN.

Sonografie břicha,

UZ nález v oblasti žlučníku, žlučových cest a jater bez pozoruhodností, pankreas při meteorismu a PEGu nevizualizován, ledviny podélné osy 12cm, kory šíře 12-15mm, bez patologie KPS, oblast sleziny pro nepřehlednost nehodnotitelná
Závěr: UZ nález v oblasti žlučníku, žlučových cest, jater a ledvin bez pozoruhodností, oblast pankreatu a sleziny pro neuspokojivou kvalitu zobrazení nehodnotitelná

ORL konzilium,

Propouštěcí zpráva - pokračování

Pacient opakovaně ošetřován i hosp. na ORL pro krustózní tracheitiduu po laryngektomii a RT pro spinoca hrtanu. Dýchá volně, bez fenoménů, poslendí kontrola kde odstraněna krusta z trachey
obj.: okolí trahceostomtu klidné, bezprostředně kolem kanálu lehce nastříklá kůže, ale neprosáklá, hladká
endoskopie: přes kanylu kanál volný, i následně trachea, jenom lehce pod kanylou hlen
th.: kanyla vytažena, vyčištěna, poté endoskopická kontrola trachey, vytažen hlen na přední stěně, jinak volné ža po karinu
Závěrtrachestoma volné

Doporučenízvyklá péče o kanylu, zvlhčovat vzduch, kontrola na ORl

Lab. nález 1
Ionty: Sodík_S/P: 120 mmol/L, Draslík_S/P: 4,3 mmol/L, Chloridy_S/P: 85 mmol/L, Vnitřní prostředí: Osmolalita_S/P: 244 mmol/kg, Renální funkce: Urea_S/P: 2,9 mmol/L, Kreatinin_S/P: 42 µmol/L, eGF z kreatininu_Q: 1,91 mL/s, Jaterní funkce: ALT_S/P: 0,18 µkat/L, AST_S/P: 0,29 µkat/L, GGT_S/P: 1,37 µkat/L, ALP_S/P: 2,11 µkat/L, Bilirubin celkový_S/P: 13,0 µmol/L, Pankreatické enzymy: AMS_S/P: 0,86 µkat/L, Lipáza_S/P: 0,47 µkat/L, Diabetes mellitus: Glukóza_S/P: 7,79 mmol/L, Markery zánětu: C reaktivní protein_S/P: < 0,5 mg/L, Nádorové markery: S-100_S: 0,137 µg/L, Krevní obraz: Leukocyty: 18,62 10^9/L, Neutrofily_analyzátor: 93,8 %, Lymfocyty_analyzátor: 1,4 %, Monocyty_analyzátor: 4,5 %, Eozinofily_analyzátor: 0,1 %, Bazofily_analyzátor: 0,2 %, Neutrofily-absolutní počet: 17,47 10^9/L, Lymfocyty-absolutní počet: 0,26 10^9/L, Monocyty-absolutní počet: 0,84 10^9/L, Eozinofily_absolutní počet: 0,01 10^9/L, Bazofily_absolutní počet: 0,04 10^9/L, Erytrocyty: 4,00 10^12/L, Hemoglobin: 120 g/L, Hematokrit: 0,330 -, MCV: 83 fL, RDW: 13,7 %, Trombocyty: 456 10^9/L, MPV: 8,3 fL, MCH: 30 pg, MCHC: 364 g/L, Komentář KO_DIF analyzátor: text, Koagulace rutina: PT-čas: 12,3 s, PT-poměr: 1,07 -, PT-INR: 1,08 -, APTT-čas: 26,6 s, APTT-poměr: 0,87 -, Fibrinogen: 3,35 g/L, TT-čas: 17,5 s, TT-poměr: 1,00 -, Antikoagulační léčba: Nezjištěno, Pomocné metody: Matrice dodaného vzorku; plazma_Pt: plazma

Lab. nález 2
Ionty: Sodík_S/P: 125 mmol/L, Draslík_S/P: 4,2 mmol/L, Chloridy_S/P: 89 mmol/L, Vápník celkový_S/P: 2,25 mmol/L, Vápník korigovaný_Q: 2,30 mmol/L, Fosfor_S/P: 1,11 mmol/L, Hořčík_S/P: 0,77 mmol/L, Kalciofosfátový součin_Q: 2,50 -, Renální funkce: Urea_S/P: 2,8 mmol/L, Kreatinin_S/P: 49 µmol/L, eGF z kreatininu_Q: 1,79 mL/s, Kyselina močová_S/P: 148 µmol/L, Markery zánětu: C reaktivní protein_S/P: 8,2 mg/L, Specifické proteiny: Celková bílkovina_S/P: 64,0 g/L, Albumin_S/P: 39 g/L, Krevní obraz: Leukocyty: 9,89 10^9/L, Neutrofily_analyzátor: 85,7 %, Lymfocyty_analyzátor: 3,2 %, Monocyty_analyzátor: 9,9 %, Eozinofily_analyzátor: 0,9 %, Bazofily_analyzátor: 0,3 %, Neutrofily-absolutní počet: 8,47 10^9/L, Lymfocyty-absolutní počet: 0,32 10^9/L, Monocyty-absolutní počet: 0,98 10^9/L, Eozinofily_absolutní počet: 0,09 10^9/L, Bazofily_absolutní počet: 0,03 10^9/L, Erytrocyty: 3,75 10^12/L, Hemoglobin: 112 g/L, Hematokrit: 0,307 -, MCV: 82 fL, RDW: 14,1 %, Trombocyty: 423 10^9/L, MPV: 8,4 fL, MCH: 30 pg, MCHC: 365 g/L, Komentář KO_DIF analyzátor: text

Lab. nález 3
Ionty: Sodík_S/P: 130 mmol/L, Draslík_S/P: 4,2 mmol/L, Chloridy_S/P: 95 mmol/L, Vápník celkový_S/P: 2,24 mmol/L, Fosfor_S/P: 0,87 mmol/L, Hořčík_S/P: 0,84 mmol/L, Kalciofosfátový součin_Q: 1,95 -, Vnitřní prostředí: Osmolalita_S/P: 262 mmol/kg

Lab. nález 4
Ionty: Sodík_S/P: 132 mmol/L, Draslík_S/P: 4,4 mmol/L, Chloridy_S/P: 95 mmol/L, Renální funkce: Urea_S/P: 4,7 mmol/L, Kreatinin_S/P: 49 µmol/L, Cystatin C_S/P: 0,94 mg/L, eGF z kreatininu_Q: 1,79 mL/s, eGF z cystatinu C_Q: 1,36 mL/s, eGF z kreatininu a cyst C_Q: 1,58 mL/s, odhad GF dle Schwartze_Q: Nelze (Věk), Kyselina močová_S/P: 171 µmol/L, NGAL_S/P: 139,3 µg/L, Markery zánětu: C reaktivní protein_S/P: 14,6 mg/L, Markery poškození svalové tkáně: Sarkopenický index: 59,0 -, Krevní obraz: Leukocyty: 8,95 10^9/L, Neutrofily_analyzátor: 82,5 %, Lymfocyty_analyzátor: 3,6 %, Monocyty_analyzátor: 11,7 %, Eozinofily_analyzátor: 1,6 %, Bazofily_analyzátor: 0,6 %, Neutrofily-absolutní počet: 7,39 10^9/L, Lymfocyty-absolutní počet: 0,32 10^9/L, Monocyty-absolutní počet: 1,05 10^9/L, Eozinofily_absolutní počet: 0,14 10^9/L, Bazofily_absolutní počet: 0,05 10^9/L, Erytrocyty: 3,85 10^12/L, Hemoglobin: 116 g/L, Hematokrit: 0,320 -, MCV: 83 fL, RDW: 14,5 %, Trombocyty: 407 10^9/L, MPV: 8,6 fL, MCH: 30 pg, MCHC: 363 g/L, Komentář KO_DIF analyzátor: text

Lab. nález 5
Ionty: Sodík_S/P: 133 mmol/L, Draslík_S/P: 4,7 mmol/L, Chloridy_S/P: 95 mmol/L

Lab. nález z 6

Propouštěcí zpráva - pokračování

Ionty: Sodík_S/P: **132**, Draslík_S/P: 4,2, Chloridy_S/P: 98

Přehled terapie:

ACIDUM FOLICUM LÉČIVA, TBL OBD, 10MG; AGEN, TBL NOB, 5MG; ALPROX, TBL NOB, 0,25MG; BERODUAL N, INH SOL PSS, 0,02MG/0,05MG/DÁV; CITALEC, TBL FLM, 20MG; ENALAPRIL VITABALANS, TBL NOB, 5MG; ENAP-H, TBL NOB, 10MG/25MG; EUTHYROX, TBL NOB, 25MCG; FLIXOTIDE INHALER N, INH SUS PSS, 125MCG/DÁV; FRESUBIN 2 KCAL DRINK , POR SOL; KINITO, TBL FLM, 50MG; MIRTAZAPIN SANDOZ, TBL FLM, 15MG; MUCOSOLVAN SOL 1X50ML; NEUROL, TBL NOB, 0,5MG; NOLPAZA, TBL ENT, 40MG; PARALEN, TBL NOB, 500MG; ROSUCARD, TBL FLM, 40MG; TIAPRALAN, TBL NOB, 100MG; TRITTICO AC, TBL MRL, 75MG; TROMBEX, TBL FLM, 75MG; ZALDIAR, TBL FLM, 37,5MG/325MG; PLASMALYTE

Průběh hospitalizace:

Polymorbidní pacient byl vstupně vyšetřen na traumatologii a neurologii pro synkopu s úderem do hlavy. Laboratorně byla přítomna hyponatrémie. K došetření byl přijat na interní oddělení. Synkopa byla hodnocena jako vazovagální. Hyponátremie byla hodnocena jako poléková (hydrochlorothiazid, citalopram) a postupně byla upravena. Pacient byl vyšetřen psychiatrem s úpravou medikace a pro potíže s tracheostomickou kanylou také ORL lékařem. Pacienta dimituje v KP komepnzovaném stavu do domácího prostředí.

Diagnostický souhrn:

Hypoosmolální hyponatrémie s hypochlorémií - poléková (hydrochlorothiazidu, citalopram)
Synkopa v.s. vasovagální etiologie
- CT mozku bez ICH

SpinoCa hrtanu, pT3N0M0, G2, R0, p16-
- 25.2.2026 st.p. totální laryngektomii + lobektomii ŠŽ l.dx. + BND bilat. II-V
- 01/26 st.p.implantaci PEG
- 04-06/26 st.p. adjuvantní RT (lůžko hypopharyngo-laryngu/LU krku bilat.)

Doporučení:

Kontrola u ošetřujícího praktického lékaře do 3 dnů s propouštěcí zprávou, léky na 3 dny vydány, odvoz vlastní.
Vhodná kontrola iontogramu s odstupem.
Dispenazarizace u ambulantních specialistů jak zavedeno.

Doporučená medikace:

Chronická medikace:
NOLPAZA, TBL ENT, 40MG, 40MG, p.o., 1-0-0;
KINITO, TBL FLM, 50MG, 50MG, p.o., 1-1-1;
TROMBEX, TBL FLM, 75MG, 75MG, p.o., 0-1-0;
ACIDUM FOLICUM LÉČIVA, TBL OBD, 10MG, 10MG, p.o., 1-0-0;
FLIXOTIDE INHALER N, INH SUS PSS, 125MCG/DÁV, 125 MCG/DÁV, inhalačně, 1-1-1;
MUCOSOLVAN SOL 1X50ML, 2 ml/F1/1 2 ml, inhalačně, 1-1-1-1
BERODUAL N, INH SOL PSS, 0,02MG/0,05MG/DÁV, inhalačně, 1-1-1
AGEN, TBL NOB, 5MG, 5MG, p.o., 1-0-1;
ENALAPRIL VITABALANS, TBL NOB, 5MG, 5MG, p.o., 1-0-1;
ROSUCARD, TBL FLM, 40MG, 40MG, p.o., 0-0-1;
EUTHYROX, TBL NOB, 25MCG, 25MCG, p.o., 1-0-0;
Linola radioderm lokálně, 3-4x denně ošetření RT pole;
Vazelina, lokální ošetření tracheostomatu po RT;
Lactulosa 667mg/ml dlp.,
ZALDIAR, TBL FLM, 37,5MG/325MG, 37,5mg/325mg, p.o., 1 - 1 - 1
TIAPRALAN, TBL NOB, 100MG, 100MG, p.o., 1 - 1 - 1;
ALPROX, TBL NOB, 0,25MG, 0,25MG, p.o., nově v dávce 1-0-1;

Nově nasazené léky:
MIRTAZAPIN SANDOZ, TBL FLM, 15MG, 15MG, p.o., 0 - 0 - 0 - 2;
TRITTICO AC, TBL MRL, 75MG, 75MG, p.o., 2/3-2/3-0; - možno navýšit až na 1-1-0

Vysazené léky:
CITALEC 20MG
Enap H 10/25mg

tel.